ONEMA-POP-003 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-003 — Conduta de Enfermagem diante de Dor

Torácica Aguda — Suspeita de Síndrome Coronariana Aguda

Objetivo

1. Reconhecer dor torácica potencialmente tempo-dependente e reduzir atraso até atendimento de emergência.

Abrangência e competência

1. Atendimento remoto por enfermeiro habilitado, respeitando limites da telenfermagem; não substitui avaliação

presencial ou serviço de emergência quando indicado.

Materiais e recursos

1. Dispositivo com acesso seguro à Carteira Digital ONEMA e telefone

2. Informações de endereço/localização e contato de emergência

3. Histórico de doenças e medicamentos, quando acessível sem retardar socorro

Preparação

1. Verificar conexão, identificação, consentimento/condições de privacidade, endereço para emergência e

disponibilidade de comunicação de contingência.

2. Não exigir que o paciente adquira materiais para uma triagem urgente.

Execução técnica — sequência padronizada

1. Confirmar identificação, endereço exato, telefone de retorno, início dos sintomas e presença de acompanhante.

2. Perguntar início, duração, localização, intensidade, irradiação e caráter da dor; investigar dispneia, sudorese, náusea,

síncope e sintomas associados.

3. Avaliar estado de consciência, fala, respiração e sinais de instabilidade observáveis; registrar medidas disponíveis

sem atrasar decisão.

4. Na suspeita de síndrome coronariana aguda ou outra causa potencialmente grave, orientar acionamento imediato do

SAMU 192; não encaminhar a pessoa dirigindo veículo próprio.

5. Manter pessoa em repouso, em posição confortável, e acompanhante por perto; não oferecer alimento, exercício ou

deslocamento desnecessário enquanto aguarda ajuda.

6. Não iniciar automaticamente AAS, nitratos ou outros medicamentos; qualquer conduta medicamentosa deve respeitar

prescrição aplicável e avaliação individual.

7. Transmitir ao serviço de emergência horário de início, sintomas, comorbidades, medicações conhecidas e mudanças

clínicas, se houver comunicação possível.

8. Registrar linha do tempo, sinais relatados, acionamento do socorro, orientações, destino conhecido e encerramento

responsável do contato.

Intercorrências, interrupção e escalonamento

1. Dor torácica aguda suspeita, especialmente persistente ou associada a dispneia, sudorese, síncope ou instabilidade:

emergência. Não retardar transferência para obter ECG ou exames no domicílio.

2. Se a comunicação cair durante situação crítica, utilizar os contatos de contingência disponíveis e documentar as

tentativas; não registrar falsa confirmação de socorro.

Cuidados posteriores e continuidade

1. Confirmar entendimento do plano, orientar acompanhante/responsável quando apropriado e registrar destino do

encaminhamento se confirmado.

2. Na modalidade presencial, portar esfigmomanômetro validado, estetoscópio, termômetro e oxímetro; aferir conforme

indicação clínica.

Registros na Carteira Digital ONEMA

1. Registrar data e horário, identificação profissional, modalidade, informações e respectivas fontes, sinais e sintomas,

avaliação, diagnóstico e planejamento de enfermagem quando aplicáveis, ações, alertas, contatos, resposta e

continuidade.

2. Preservar a trilha de auditoria; a Kary pode organizar dados, mas não diagnosticar, prescrever ou decidir alta.

Referências técnicas

1. COFEN, Resolução 736/2024 — https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/

2. AHA/ACC, Guideline for Evaluation and Diagnosis of Chest Pain, 2021 —

https://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j.jacc.2021.07.053